

Dr. Alexandre Guerreiro da Fonseca
Ortopedia e Traumatologia
Título de Especialista – SBOT – SLAOT – AMB – MEC
Médico do Trabalho
CRM – SP 32.692 – CPF 295.892.317/72
TEOT 3.231 – DRT 14.702



Alessandro Roberto dos Reis Santos

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, de acordo com a Resolução CFM 1.658/02 que **Alessandro Roberto dos Reis Santos** (RG 34.555.246-5; CPF 213.930.008-43) é portador **Deficiência Física Adquirida** (Pessoa com Deficiência - PCD) segundo legislação vigente (Lei 13.146/2015 ; Lei 8.989/1995; Lei 14.287/2021) apresentando :

I – Diagnóstico:

Coluna Cervical :

- Retificação da lordose – M40.3
- Osteofitos– M25.7
- Protusão discal em C3-C4; C5-C6 e C6-C7 – M50.1
- Compressão de saco dural em C3-C4; C5-C6 e C6-C7 – M50.8
- Abaulamento discal c4-C5 – M50.1
- Redução foraminal C4-C5 e C6-C7 – M54.1

Coluna lombar:

- Espondilose – M47.9
- Discopatia degenerativa – M51.9
- **Síndrome dolorosa pós-laminectomia direita L4-L5 com alteração de planos gordurosos adjacentes – M96.1**
- Complexo disco osteofitário difuso em L4-L5 – M51.1/M25.7
- **Protusão discal postero mediana em L4-L5, mediana e para mediana direita em L5-S1 – M51.1**
- **Abaulamento discal em L5-S1 – M51.1**
- **Migração caudal discal em L4-L5 – G55.1**

Consultório : Avenida Andrômeda, 433 sala 212 – Satélite – Tel/Fax 39 39 20 36

“II – O alvo de toda atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional”

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS - Código de Ética Médica
Resolução CFM nº 1.931 de 17/09/09

2º TABELIAO
Alexandre Guerreiro da Fonseca
Ortopedia e Traumatologia
CRM 32.692 - TEOT 3.231
Av. Andrômeda, 433 - Sala 212
Telefone: 3939-2036

Dr. Alexandre Guerreiro da Fonseca
Ortopedia e Traumatologia
Título de Especialista – SBOT – SLAOT – AMB – MEC
Médico do Trabalho
CRM – SP 32.692 – CPF 295.892.317/72
TEOT 3.231 – DRT 14.702

- Compressão de saco dural em L4-L5 e L5-S1 – M51.8
- Fissura radial em L4-L5 e L5-S1 – M51.8
- Redução foraminal L4-L5 e L5-S1 – M54.1

II – Resultados de exames:

Ressonância magnética de 31/08/22 com laudo anexo.

III – Conduta terapeutica:

Submetido a laminectomia em 2015 com re-operação após 7 dias (intercorrência) estando atualmente em tratamento medicamentoso e fisioterápico.

IV – Prognóstico:

Quadro crônico irreversível, levando a uma incapacidade funcional parcial e permanente deficiência física adquirida. Com benefício previdenciário espécie B94.

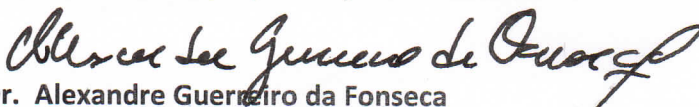
V – Consequências:

Apresenta para paresia em membro inferior direito, com redução aos graus iniciais de mobilidade lombar (redução grau máximo/acima de 2/3 – lombo sacro).

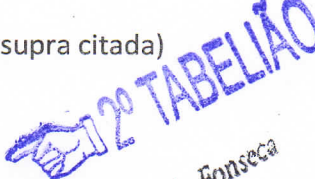
O desempenho muscular da coluna está prejudicado pelo quadro algico aos graus iniciais de mobilidade e não gravidade, mas podendo ser considerado pobre (grau 2).

Caracteriza deficiência física adquirida nos termo da lei (supra citada)

São José dos Campos, 23 de janeiro de 2023.


Dr. Alexandre Guerreiro da Fonseca

CRM 32.692/TEOT 3.231/RQE 54.195/DRT 14.702.


Alexandre Guerreiro da Fonseca
Ortopedia e Traumatologia
CRM 32.692 - TEOT 3.231
Av. Andrômeda, 433 - Sala 212
Telefone: 3939-2036

Consultório : Avenida Andrômeda, 433 sala 212 – Satélite – Tel/Fax 39 39 20 36

“II – O alvo de toda atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional”

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS - Código de Ética Médica
Resolução CFM nº 1.931 de 17/09/09



Dr. Elisio Barros Avidago

CRM:73309

Relatório Médico

O paciente ALESSANDRO ROBERTO DOS REIS SANTOS foi submetido a cirurgia para tratamento de hérnia de disco L4-L5. Teve melhora total da dor após a cirurgia, porém após 5 dias, evoluiu com novo quadro de dor lombar com irradiação para MID, sendo submetido a nova cirurgia. Evoluiu muito bem, com melhora total da dor. Tem também queixa de dor cervical crônica. Esporadicamente tem episódios de dor lombar com períodos de agudização da dor, quando refere contratura paravertebral com "travamento" na coluna lombar (SIC). RM de coluna atual mostra discopatia L4-L5 e L5-S1, com protusões discais + sinais de artrose facetária. RM de coluna cervical mostra discopatia de C3 a C7, com protusões discais. Devido à patologia de coluna lombar e cervical, ao passado de tratamento cirúrgico na coluna lombar e à queixa de "episódios de dor lombar", o paciente foi orientado a manter uma atividade física direcionada para alongamento e fortalecimento de musculatura de cintura pélvica e escapular, além de orientações posturais.

O paciente tem limitações físicas definitivas, não podendo exercer funções que necessite "pegar" objetos pesados, movimentos repetitivos de flexão e rotação de coluna vertebral, permanecer longos períodos em posição ortostática.

CID: M51.1 (M54.5) + M54.2

São José Dos Campos, 04 de Outubro de 2022

Elisio Barros Avidago
CRM73309
Neurocirurgia
Cirurgião de Coluna

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SUS

ATESTADO MEDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO CFM 1.658/02, QUE ALESSANDRO ROBERTO DOS REIS SANTOS, RG 34555246-5 E CPF 213930008-43, É PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA ADQUIRIDA (PCD), SEGUNDO LEGISLACAO VIGENTE (LEI 13.146/2015; LEI 8.989/1995; LEI 14.287/2021) APRESENTANDO:

I – DIAGNOSTICO

COLUNA CERVICAL:

RETIFICACAO DA LORDOSE – M40.3

OSTEOFITOS – M25.7

PROTRUSAO DISCAL – M50.1

COMPRESSAO DE SACO DURAL – M50.8

ABAUAMENTO DISCAL – M50.1

REDUCAO FORAMINAL – M54.1

COLUNA LOMBAR:

ESPONDILOSE – M47.9

DISCOPATIA DEGENERATIVA – M51.9

SINDROME DOLOROSA POS-LAMINECTOMIA DIREITA L4/L5 COM ALTERACOES DE PLANOS GORDUROSOS ADJASCENTES – **M96.1**

COMPLEXO DISCO-OSTEOFITARIO DIFUSO EM L4/L5 – M51.1 / M25.7

PROTRUSAO DISCAL POSTERO MEDIANA EM L4/L5, MEDIANA E PARA-MEDIANA EM L5/S1 – **M51.1**

ABAUAMENTO DISCAL EM L5/S1 – **M51.1**

MIGRACAO CAUDAL DISCAL EM L4/L5 – **G55.1**

COMPRESSAO DE SACO DURAL EM L4/L5 E L5/S1 –M51.8

FISSURA RADIAL EM L4/L5 E L5/S1 – M51.8

REDUCAO FORAMINAL L4/L5 E L5/S1 – M54.1

II- RESULTADO DE EXAMES:

RESSONANCIA MAGNETICA DE 31/08/2022, COM LAUDO EM ANEXO.

III – CONDUTA TERAPEUTICA:

SUBMETIDO A LAMINECTOMIA EM 2015, COM REOPERACAO APÓS 7 DIAS, ESTANDO ATUALMENTE EM TRATAMENTO MEDICAMENTOSO E FISIOTERAPICO.

IV – PROGNOSTICO:

QUADRO CRONICO IRREVERSIVEL, LEVANDO A UMA INCAPACIDADE FUNCIONAL PARCIAL E PERMANENTE DEFICIENCIA FISICA ADQUIRIDA, COM BENEFICIO PREVIDENCIARIO ESPECIE B94.

V – CONSEQUENCIAS:

APRESENTA PARA-PARESIA EM MEMBRO INFERIOR DIREITO, COM REDUCAO AOS GRAUS INICIAIS DE MOBILIDADE LOMBAR (REDUCAO GRAU MAXIMO/ACIMA DE 2/3 – LOMBO-SACRO).

O DESEMPENHO MUSCULAR DA COLUNA ESTÁ PREJUDICADO PELO QUADRO ALGICO AOS GRAUS INICIAIS DE MOBILIDADE E NÃO GRAVIDADE, MAS PODENDO SER CONSIDERADO POBRE (GRAU 2).

CARACTERIZA DEFICIENCIA FISICA ADQUIRIDA NOS TERMOS DA LEI (SUPRA CITADA).

ATENCIOSAMENTE,

DR. RICARDO MENEZES
CREMESP 87184

26 JUN 2024

DR. RICARDO MENEZES DE ANDRADE

Receita

 Prefeitura de São José dos Campos Secretaria Municipal de Saúde SAMS - Sistema de Atendimento Municipal de Saúde	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE
---	--

RECEITUÁRIO MÉDICO

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SUS

Para: ALESSANDRO ROBERTO DOS REIS SANTOS
End:
CPF: 213.930.008-43

RELATORIO MEDICO

RELATO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O PACIENTE ACIMA IDENTIFICADO É PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA ADQUIRIDA (PCD), COM ESPONDILOARTROSE, DISCOPATIAS DIFUSAS E HERNIAS DISCAIS CERVICAL E LOMBAR.

JÁ SUBMETIDO A TRATAMENTO CIRURGICO DE HERNIA DISCAL LOMBAR, PERSISTE COM DORES CRONICAS RELACIONADAS À COLUMNA E NERVO CIÁTICO. DORES ESTAS DE DIFÍCIL CONTROLE, COM PREJUÍZO DE SUA CAPACIDADE LABORAL, LOCOMOÇÃO E MOBILIDADE. ATUALMENTE, FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA, PARA CONTROLE DE DOR CRONICA E EXERCÍCIOS FÍSICOS LEVES.

TAL QUADRO APRESENTA-SE DE CARATER DEGENERATIVO- PROGRESSIVO E DEFINITIVO.

CID: M51.1
M54.4
M54.2
M19.9
M25.5

Dr. Ricardo Menezes de Andrade
Crm 87184
CPF: 131.309.718-74

DR. RICARDO MENEZES
CREMESP 87184

12 JUN. 2024

Handwritten signature of Ricardo Menezes de Andrade
2º TABELIÃO

2º TABELIÃO DE NOTAS
Tabelião Interino - Pedro Henrique de Oliveira

Reconheço por semelhança (doc s/vr econ) a firma indicada de
RICARDO MENEZES DE ANDRADE
que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
São José dos Campos, 03 de julho de 2024. Em testemunho da presente

Mônica Fátima Cardoso Lima (Escrivente)
Valor Total R\$ 8,37 Selo: AA-00622335

Av. Eng. Fco Jose Longo, 149
loja 7/9/12 - Fone: (12) 3921-8022
São José dos Campos/SP

“VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE”

2º TABELIÃO DE NOTAS
Mônica Fátima Cardoso Lima
ESCRIVENTE

123869
FIRMA 1 - ON (12) 3921-6248
S11003AA0622335
Av. Eng. Fco Jose Longo, 149 - Lojas 7-9-12
São José dos Campos - SP

Nome: ALESSANDRO ROBERTO DOS REIS SANTOS
Solicitante: Dr(a).: RICARDO MENEZES DE ANDRADE
Prontuário: 475885 **Atendimento:** 013 - 0460856 **Data:** 22/06/2023

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR

TÉCNICA:

Exame realizado com sequências multiplanares TSE T2 sem e com supressão de gordura e TSE T1.

ANÁLISE:

Discreto desvio do eixo longitudinal da coluna lombar com convexidade à direita.

Laminectomia à direita em L4-L5, com discreta alteração dos planos músculo gordurosos adjacentes.

Corpos vertebrais com altura preservada, apresentando pequenos osteófitos periféricos.

Alterações degenerativas subcondrais nos platôs vertebrais contíguos L4-L5 e L5-S1.

Pedículos íntegros.

Articulações interapofisárias sem alterações.

Degeneração dos discos intervertebrais L4-L5 e L5-S1.

Abaulamento discal difuso em L3-L4, tocando a face ventral do saco dural e reduzindo discretamente a amplitude do recesso inferior dos respectivos forames neurais.

Complexo disco-osteofitário difuso em L4-L5, associada a protrusão discal póstero-mediana, com pequena migração inferior, causando compressão do saco dural e reduzindo a amplitude do recesso inferior dos respectivos forames neurais.

Abaulamento discal difuso em L5-S1, associada a protrusão discal mediana e paramediana à direita, causando compressão do saco dural e reduzindo a amplitude do recesso inferior dos respectivos forames neurais.

Demais forames neurais amplos.

O cone medular foi visualizado ao nível do corpo de L1 e não apresenta alterações.

Distribuição normal das fibras da cauda equina.

Nome: ALESSANDRO ROBERTO DOS REIS SANTOS
Solicitante: Dr(a).: RICARDO MENEZES DE ANDRADE
Prontuário: 475885 **Atendimento:** 013 - 0460856 **Data:** 22/06/2023

O canal vertebral é de dimensões normais por toda a extensão estudada.

Mínimo edema na topografia dos ligamentos interespinhosos em L3-L4, L4-L5 e L5-S1, por sobrecarga mecânica.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Discreta espondilose lombar.

Laminectomia à direita em L4-L5, com discreta alteração dos planos músculo gordurosos adjacentes.

Discopatia degenerativa em L4-L5 e L5-S1.

Abaulamento discal difuso em L3-L4, tocando a face ventral do saco dural e reduzindo discretamente a amplitude do recesso inferior dos respectivos forames neurais.

Complexo disco-osteofitário difuso em L4-L5, associada a protrusão discal pósteromediana, com pequena migração inferior, causando compressão do saco dural e reduzindo a amplitude do recesso inferior dos respectivos forames neurais.

Abaulamento discal difuso em L5-S1, associada a protrusão discal mediana e paramediana à direita, causando compressão do saco dural e reduzindo a amplitude do recesso inferior dos respectivos forames neurais.

Mínimo edema na topografia dos ligamentos interespinhosos em L3-L4, L4-L5 e L5-S1, por sobrecarga mecânica.

Nome: ALESSANDRO ROBERTO DOS REIS SANTOS
Solicitante: Dr(a).: RICARDO MENEZES DE ANDRADE
Prontuário: 475885 **Atendimento:** 013 - 0460856 **Data:** 22/06/2023

Helcyneire Utrini

DRA. HELCYMEIRE CASTRO UTRINI CRM: 123333



Faça a leitura do QRCode
para visualização das imagens
deste Laudo

NOME: ALESSANDRO ROBERTO DOS REIS SANTOS
SOLICITANTE: Dr(a): JOAO PAULO FREIRE MARTINS DE MOURA
Prontuário: 475885 **Atendimento:** 021 - 0318981 **Data:** 31/08/2022

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR

TÉCNICA:

Exame realizado com sequências multiplanares TSE T2 sem e com supressão de gordura e TSE T1.

ANÁLISE:

Discreto desvio do eixo longitudinal da coluna lombar com convexidade à direita.

Corpos vertebrais com altura preservada, apresentando pequenos osteófitos periféricos.

Alterações degenerativas subcondrais nos platôs vertebrais contíguos L4-L5 e L5-S1.

Pedículos íntegros.

Articulações interapofisárias sem alterações.

Degeneração dos discos intervertebrais L4-L5, L5-S1.

Laminectomia à direita em L4-L5, com discreta alteração dos planos músculo gordurosos adjacentes.

Complexo disco-osteofitário difuso em L4-L5, associada a protrusão discal pósteromediana, com pequena migração inferior e sinais de fissura radial, causando compressão do saco dural e reduzindo a amplitude do recesso inferior dos respectivos forames neurais.

Abaulamento discal difuso em L5-S1, associada a protrusão discal mediana e paramediana à direita, com sinais de fissura radial, causando compressão do saco dural e reduzindo a amplitude do recesso inferior dos respectivos forames neurais.

Demais forames neurais amplos.

O cone medular foi visualizado ao nível do corpo de L1 e não apresenta alterações.

Distribuição normal das fibras da cauda equina.

O canal vertebral é de dimensões normais por toda a extensão estudada.

Mínimo edema na topografia dos ligamentos interespinhosos em L3-L4, L4-L5 e L5-S1, por sobrecarga mecânica.

NOME: ALESSANDRO ROBERTO DOS REIS SANTOS
SOLICITANTE: Dr(a): JOAO PAULO FREIRE MARTINS DE MOURA
Prontuário: 475885 **Atendimento:** 021 - 0318981 **Data:** 31/08/2022

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Discreta espondilose lombar.

Discopatia degenerativa em L4-L5 e L5-S1.

Laminectomia à direita em L4-L5, com discreta alteração dos planos músculo gordurosos adjacentes.

Complexo disco-osteofitário difuso em L4-L5, associada a protrusão discal pósteromediana, com pequena migração inferior e sinais de fissura radial, causando compressão do saco dural e reduzindo a amplitude do recesso inferior dos respectivos forames neurais.

Abaulamento discal difuso em L5-S1, associada a protrusão discal mediana e paramediana à direita, com sinais de fissura radial, causando compressão do saco dural e reduzindo a amplitude do recesso inferior dos respectivos forames neurais.

Mínimo edema na topografia dos ligamentos interespinhosos em L3-L4, L4-L5 e L5-S1, por sobrecarga mecânica.



DRA. HELCYMEIRE CASTRO UTRINI CRM: 123333

NOME: ALESSANDRO ROBERTO DOS REIS SANTOS
SOLICITANTE: Dr(a): JOAO PAULO FREIRE MARTINS DE MOURA
Prontuário: 475885 **Atendimento:** 021 - 0318981 **Data:** 31/08/2022

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL

TÉCNICA:

Exame realizado com sequências multiplanares: TSE T2 e T1, Balance e GRE T2.

ANÁLISE:

Retificação do eixo da coluna cervical.

Corpos vertebrais com altura preservada, apresentando pequenos osteófitos periféricos.

Arcos posteriores íntegros.

Articulações uncovertebrais e interapofisárias sem alterações.

Desidratação dos discos intervertebrais cervicais.

Protrusão discal póstero-mediana em C3-C4, causando compressão do saco dural.

Abaulamento discal difuso em C4-C5, associada a protrusão discal médio látero-foraminal à direita, causando compressão do saco dural e reduzindo a amplitude do recesso inferior dos respectivos forames neurais.

Protrusão discal mediana e paramediana esquerda em C5-C6, causando compressão do saco dural.

Protrusão discal médio-lateral esquerda em C6-C7, causando compressão do saco dural, causando compressão do saco dural e reduzem discretamente a amplitude do recesso inferior do forame neural à esquerda.

Demais forames neurais amplos.

A medula tem forma, volume e intensidade de sinal habituais.

O diâmetro do canal raquiano é de dimensões normais por toda extensão estudada.

Transição crânio-cervical normal.

NOME: ALESSANDRO ROBERTO DOS REIS SANTOS
SOLICITANTE: Dr(a): JOAO PAULO FREIRE MARTINS DE MOURA
Prontuário: 475885 **Atendimento:** 021 - 0318981 **Data:** 31/08/2022

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Retificação do eixo da coluna cervical.

Espondilose cervical.

Desidratação dos discos intervertebrais cervicais.

Protrusão discal póstero-mediana em C3-C4, causando compressão do saco dural.

Abaulamento discal difuso em C4-C5, associada a protrusão discal médio látero-foraminal à direita, causando compressão do saco dural e reduzindo a amplitude do recesso inferior dos respectivos forames neurais.

Protrusão discal mediana e paramediana esquerda em C5-C6, causando compressão do saco dural.

Protrusão discal médio-lateral esquerda em C6-C7, causando compressão do saco dural, causando compressão do saco dural e reduzem discretamente a amplitude do recesso inferior do forame neural à esquerda.



DRA. HELCYMEIRE CASTRO UTRINI CRM: 123333

NOME: ALESSANDRO ROBERTO DOS REIS SANTOS
SOLICITANTE: Dr(a): ELISIO BARROS AVIDAGO
Prontuário: 475885 **Atendimento:** 021 - 0173069 **Data:** 02/10/2020

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR

TÉCNICA:

Exame realizado com sequências multiplanares TSE T2 sem e com supressão de gordura e TSE T1.

ANÁLISE:

Postura escoliótica lombar de convexidade direita.

Osteófitos nos corpos vertebrais.

Alteração de sinal e irregularidades de natureza degenerativa nos platôs vertebrais apostos de L4-L5.

Artefatos de susceptibilidade magnética nos planos musculares e gordurosos paravertebrais posteriores à direita no segmento correspondente à L4-L5.

Artrose interfacetária incipiente L4-L5 e L5-S1.

Desidratação parcial dos discos intervertebrais L4-L5 e L5-S1.

Protrusão discal posterior com sinais de fissura radial de L4-L5 comprimindo o saco dural e comprometendo os recessos inferiores dos forames neurais.

Protrusão discal póstero-central com sinais de fissura radial de L5-S1 comprimindo o saco dural e comprometendo os forames neurais, notadamente o direito.

Não há evidência de processos expansivos intra ou extra-raquianos.

O cone medular foi visualizado ao nível do corpo de L1 e não apresenta alterações.

Distribuição normal das fibras da cauda equina.

O canal vertebral é de dimensões normais por toda a extensão estudada.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Espondilose lombar. Postura escoliótica lombar de convexidade direita..

Protrusão discal posterior com sinais de fissura radial de L4-L5 comprimindo o saco dural e comprometendo os recessos inferiores dos forames neurais.

Protrusão discal póstero-central com sinais de fissura radial de L5-S1 comprimindo o saco dural e comprometendo os forames neurais, notadamente o direito.

NOME: ALESSANDRO ROBERTO DOS REIS SANTOS

SOLICITANTE: Dr(a): ELISIO BARROS AVIDAGO

Prontuário: 475885

Atendimento: 021 - 0173069

Data: 02/10/2020



DRA MAIRA S. TUBAGI - CRM 119554

NOME: ALESSANDRO ROBERTO DOS REIS SANTOS
SOLICITANTE: Dr(a): ELISIO BARROS AVIDAGO
Prontuário: 475885 **Atendimento:** 021 - 0173069 **Data:** 02/10/2020

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL

TÉCNICA:

Exame realizado com sequências multiplanares: TSE T2 e T1, Balance e GRE T2.

ANÁLISE:

Corpos vertebrais com morfologia e intensidade de sinal preservadas.

Arcos posteriores íntegros.

Articulações uncovertebrais e interapofisárias sem alterações.

Retificação do eixo seus posterior cervical.

Pequenos osteófitos nos corpos vertebrais.

Desidratação e sinal dos discos intervertebrais.

Abaulamentos discais posteriores de C3-C4 a C6-C7 determinando compressões no saco dural.

Os forâmens de conjugação estão livres.

A medula tem forma, volume e intensidade de sinal habituais.

Não foram observadas lesões ocupando espaço no interior do canal raquiano.

O diâmetro do canal raquiano é de dimensões normais por toda extensão estudada.

Transição crânio-cervical normal.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Retificação do eixo seus posterior cervical.

Pequenos osteófitos nos corpos vertebrais.

Desidratação e sinal dos discos intervertebrais.

Abaulamentos discais posteriores de C3-C4 a C6-C7 determinando compressões no saco dural.

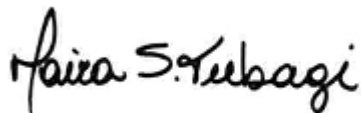
NOME: ALESSANDRO ROBERTO DOS REIS SANTOS

SOLICITANTE: Dr(a): ELISIO BARROS AVIDAGO

Prontuário: 475885

Atendimento: 021 - 0173069

Data: 02/10/2020



DRA MAIRA S. TUBAGI - CRM 119554